

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, dieses Dokument erklärt alles Wichtige rund um Ihre Weisheitszahnentfernung – von der Vorbereitung über den Eingriff bis zur vollständigen Heilung. Die Lesedauer beträgt etwa 8–10 Minuten. Bitte lesen Sie die Seite einmal vollständig vor dem Termin. Sie ersetzt nicht das persönliche Aufklärungsgespräch, fasst aber alle besprochenen Informationen vollständig zusammen.

1 · WARUM MÜSSEN WEISHEITSAHNE ENTFERNT WERDEN?

Häufige Gründe für die Entfernung

- **Platzmangel & Druck:** Schiefe Weisheitszähne drücken gegen Nachbarzähne und können diese dauerhaft schädigen
- **Erschwerte Hygiene:** Hinterste Ecken sind kaum reinigbar → Karies, Zahnfleischentzündungen
- **Schleimhautverletzungen:** Seitlich wachsende Oberkieferzähne scheuern chronisch die Wange auf
- **Zystenbildung:** Verlagerte Zähne können Zysten bilden, die den Kieferknochen schwächen
- **Akute Entzündung:** Wiederkehrende Perikoronitis / Zahnfleischtaschen um den Weisheitszahn

Was passiert, wenn man nichts tut?

Das Belassen des Zahnes ist grundsätzlich möglich, wird von uns aber bei bestehender Indikation nicht empfohlen.

Mögliche Folgen:

- Fortschreitende Entzündungen mit Ausbreitung in die Umgebung
- Knochenverlust am Nachbarzahn (Zahn 7 häufig betroffen)
- Wachstum der Zyste mit zunehmender Knochenschwächung
- Mit zunehmendem Alter werden Eingriff und Heilung aufwändiger
- Im Alter > 35 Jahre steigt das Risiko für Komplikationen deutlich

Günstiger Zeitpunkt: Im Alter von etwa 14–25 Jahren ist die Entfernung bei erkennbarer Risikokonstellation häufig gut verantwortbar: Die Heilung ist meist unkomplizierter, und spätere Schäden an Nachbarzähnen oder wiederkehrende Entzündungen können vermieden werden.

Warum wir bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen eher zur Entfernung raten: Wenn im Röntgenbild erkennbar ist, dass Weisheitszähne vorhanden sind, nicht genug Platz haben und voraussichtlich nicht regulär in die Zahnreihe einwachsen können, empfehlen wir die Entfernung häufig im Alter von etwa 14–25 Jahren. In dieser Situation ist nicht das bloße Vorhandensein des Zahnes entscheidend, sondern die erkennbare Risikokonstellation: Platzmangel, Teilretention, ungünstige Kippung, erschwerte Hygiene, wiederkehrende Entzündungen oder drohende Schäden am Nachbarzahn. Mit zunehmendem Alter verschiebt sich die Abwägung: Ohne Beschwerden und ohne erkennbare Schädigung wird eher kontrolliert; bei Schmerzen, Entzündung, Karies, Zystenbildung oder Schaden am Nachbarzahn wird therapeutisch entfernt.

2 · VORBEREITUNG VOR DEM EINGRIFF

Schmerzmittel vorab

Nehmen Sie idealerweise **1 Stunde vor dem Eingriff** das rezeptierte Schmerzmittel ein. Es wirkt bereits im Gewebe, wenn die Betäubung nach dem Eingriff nachlässt – das reduziert den Nachschmerz erheblich.

Kein Aspirin / ASS!

Meiden Sie ca. **1 Woche vor dem Eingriff** Aspirin (ASS) und andere blutverdünnende Schmerzmedikamente. Sie erhöhen das Nachblutungsrisiko massiv. Bei Schmerzen: Ibuprofen oder Paracetamol nehmen.

Antibiotika-Vorbeugung

In bestimmten Fällen (Vorerkrankungen, erhöhtes Infektionsrisiko) ist eine prophylaktische Antibiotikaeinnahme vor dem Eingriff sinnvoll. Ob das bei Ihnen notwendig ist, wurde individuell mit Ihnen besprochen.

3 · ABLAUF DES EINGRIFFS

Oberkiefer

Das Zahnfleisch wird vorsichtig eröffnet. Der Knochen im Oberkiefer ist weicher und elastischer; je nach Lage wird Knochen minimal und schonend abgetragen. In den meisten Fällen wird der Zahn anschließend gelockert und direkt entfernt – ein vergleichsweise unkompliziertes Verfahren.

Die Wunde wird mit einigen Stichen vernäht. Die **Fäden werden nach 1–2 Wochen** beim Kontrolltermin entfernt.

Unterkiefer

Auch im Unterkiefer wird das Zahnfleisch vorsichtig eröffnet. Der Unterkieferknochen ist dichter. Um den Zahn schonend zu entfernen und starken Druck zu vermeiden, tragen wir minimal Knochen ab und teilen den Zahn ggf. in Segmente, die dann einzeln herausgehoben werden.

Anschließend wird die Wunde mit einigen Stichen vernäht. Die **Fäden werden nach 1–2 Wochen** beim Kontrolltermin entfernt.

OP-Dauer: Bei Entfernung aller vier Weisheitszähne beträgt die reine Operationszeit insgesamt meist ca. 20–30 Minuten. Die gesamte Termindauer beträgt ca. 60 Minuten, weil Vorgespräch, Lokalanästhesie bzw. Anästhesievorbereitung und Abschlussgespräch dazukommen.

Eine Sitzung oder seitenweise: Wenn alle vier Weisheitszähne entfernt werden müssen, ist beides möglich. Der vermutete Vorteil der seitenweisen Entfernung ist aber oft kleiner als erwartet: Die einzelne Behandlung ist zwar kürzer, und theoretisch kann man auf der Gegenseite besser kauen. Da der Unterkiefer sich jedoch als Einheit bewegt, sind Mundöffnung und Kauen auch nach einer einseitigen Operation häufig eingeschränkt. Deshalb empfehlen wir, sofern medizinisch nichts dagegen spricht, meist die Entfernung aller vier Weisheitszähne in einer Sitzung. Besonders bei Dämmerschlaf oder Vollnarkose ist das medizinisch sehr sinnvoll, weil Narkosevorbereitung, Überwachung, Erholungsphase und Schwellung nur einmal durchlaufen werden müssen.

Knochenheilung: Der durch die Zahnentfernung entstandene Knochendefekt füllt sich innerhalb von etwa 6 Monaten wieder vollständig mit Knochen auf. Es bleiben keine knöchernen Narben und keine erhöhte Bruchgefährdung zurück.

4 · BETÄUBUNG, SEDIERUNG UND NARKOSE

Ihre Wahlmöglichkeiten im Überblick

Methode	Beschreibung	Kosten
Lokalanästhesie (Standard)	Wach, kein Schmerz – Sie spüren Druck und Bewegung. ÖPNV nach Hause erlaubt.	Kassenleistung
Orale Sedierung (Tablette) (Komfort)	Beruhigende Tablette ca. 60 Min. vorher. Sie schlafen nicht – Stress und Angstgefühl werden deutlich reduziert. Vitalparameter werden überwacht. Begleitperson, 24 h nicht verkehrsfähig. Abholung aus der Praxis verpflichtend.	ca. 80 € Eigenleistung
Dämmerschlaf (i.v.) (Komfort)	Professionelles Narkoseteam bringt Sie an die Schlaf-Wachgrenze. Kooperativ, aber keine Erinnerung an Behandlungsdetails. Druckempfinden wird genommen. Postop. Aufwachraum mit Vitalüberwachung. Nur dienstags. Nüchtern: 6 Std. vor OP nichts essen, 2 Std. vorher nichts mehr trinken; bis dahin nur klare Flüssigkeiten. Abholung aus der Praxis verpflichtend.	ca. 230 € Eigenleistung
Vollnarkose (Komfort)	Echter Tiefschlaf. Beatmung über die Nase in die Lunge. Keine Wahrnehmung des Eingriffs. Postop. Aufwachraum mit Vitalüberwachung. Nur dienstags. Nüchtern: 6 Std. vor OP nichts essen, 2 Std. vorher nichts mehr trinken; bis dahin nur klare Flüssigkeiten. Abholung aus der Praxis verpflichtend.	ca. 450 € Eigenleistung

Standard ist die Lokalanästhesie – für die allermeisten Patienten vollkommen ausreichend. Sedierung ist eine optionale Komfortzubuchung als Eigenleistung. Bei keiner Methode spüren Sie Schmerzen – die Betäubung wirkt vollständig, bevor wir beginnen.

5 · MÖGLICHE RISIKEN UND KOMPLIKATIONEN

Nervschaden (Unterkiefer) – vorübergehend häufiger, dauerhaft < 0,1 %

Der Unterkiefernerve (N. alveolaris inferior) verläuft direkt unter den Wurzeln. Eine Reizung kann zu vorübergehendem Taubheitsgefühl an Unterlippe, Kinn oder Zunge führen. Dauerhafter Schaden ist sehr selten. Es tritt dabei keine sichtbare Lähmung auf.

Kieferhöhleneröffnung (Oberkiefer) – 5–10 %

Oberkieferwurzeln ragen anatomisch oft bis in die Kieferhöhle. Wird diese bei der Entfernung eröffnet, ist das anatomisch bedingt und kein Behandlungsfehler. Wir verschließen die Öffnung sofort mit einer Naht. Nach der OP: 14 Tage nicht Nase schnäuzen, nur hochziehen. Niesen nur mit weit geöffnetem Mund.

Wundheilungsstörung – „Trockene Alveole“ – 2–4 % (Raucher bis 20 %!)

Der schützende Blutpfropf löst sich zu früh auf, der Knochen liegt frei. Ab Tag 3–5 starke Schmerzen. Gut behandelbar mit speziellen Einlagen. Wichtigste Vorbeugung: nicht rauchen.

Infektion – 2–5 %

Kann trotz sorgfältiger Technik auftreten. Zeichen: Schwellung mit Wärme und Rötung, Eiter, ansteigendes Fieber. In der Regel gut mit Antibiotika behandelbar.

Nachblutung – selten

Leichtes Nachbluten und blutig gefärbter Speichel in den ersten Stunden ist normal. Bei anhaltend starker Blutung: Tupfer fest aufbeißen (30 Min.), dann ggf. erneut vorstellig werden.

Benachbarte Zähne & Wurzelreste – < 0,5 %

Sehr selten werden Nachbarzähne (Zahn 7) berührt. Kleine Wurzelreste können bei zu hohem Entfernungsrisiko im Knochen belassen und beobachtet werden.

Kieferklemme – vorübergehend häufig, ausgeprägt selten

Eingeschränkte Mundöffnung durch Schwellung und Muskelreizung ist in den ersten Tagen normal und klingt von selbst ab.

Sehr seltene Risiken – < 0,01 %

Kieferbruch (nur bei stark verlagerten Zähnen, Wochen nach OP), allergische Reaktion auf Anästhetika, versehentliches Verschlucken von Zahnteilen.

Besondere Hinweise bei Vorerkrankungen

Der folgende Abschnitt ist für die **Mehrzahl junger, gesunder Patienten nicht relevant**. Bei älteren Patienten oder Patienten mit Vorerkrankungen bitte vor dem Eingriff mitteilen:

Blutverdünner (Antikoagulation)

Marcumar, Xarelto, Eliquis, Lixiana, Pradaxa, ASS-Dauermedikation, Clopidogrel. INR-Anpassung vor Eingriff notwendig; wir koordinieren mit Ihrem Arzt. **Nicht eigenständig absetzen**.

Bisphosphonate / Denosumab

Z. B. wegen Osteoporose oder Tumorerkrankung – auch wenn schon Jahre abgesetzt. Erhöhtes Risiko für Kieferknochennekrose (MRONJ). Medikamentenname, Einnahmedauer und letzte Einnahme bitte mitteilen.

Diabetes

Erhöhte Anfälligkeit für Wundheilungsstörungen und trockene Alveole. Aktuellen HbA1c-Wert mitteilen, falls bekannt.

Immunsuppression / Kortison / Strahlentherapie

Erhöhtes Infektionsrisiko. Strahlentherapie im Kopf-Hals-Bereich erhöht Nekrosorisiko langfristig. Bitte vollständig mitteilen.

6 · VERHALTEN NACH DEM EINGRIFF**Sofortmaßnahmen**

- Beißtupfer 30–60 Min. fest halten
- Oberkörper **erhöht lagern**, schonen
- **Nicht spucken**, nicht intensiv spülen
- **Kein Strohhalm** – Unterdruck öffnet Wunde
- Erst essen wenn **Betäubung** vollständig weg

Beißtupfer wirklich konstant halten:

Bitte 30–60 Minuten fest zubeißen und nicht immer wieder nachschauen. Jedes Herausnehmen kann den frischen Blutpfropf lösen, sodass die Nachblutung erneut beginnt.

- **Rauchen, Alkohol, Kaffee, Energydrinks:** mind. 3 Tage, besser 1 Woche meiden. Rauchen → bis zu 20 % Alveolitis-Risiko!

Kühlen – richtig!

- **Feuchtes, handwarmes Tuch** (~17 °C) – 10–15 Min., Pause, wiederholen
- **Kein Eis, keine Kühlpacks!**
Unterkühlung fördert Nachblutung und verstärkt Schwellung
- Schwellung **normal**, Höhepunkt Tag 2–3
- Blaue Flecken an der Wange sind ebenfalls normal
- Schwellung klingt nach Tag 3 von selbst ab

Warum kein Eis? Zu kalte Kühlung führt zuerst zur Unterkühlung. Sobald sie weggenommen wird, durchblutet der Körper das Areal besonders stark. Das kann blaue Flecken, Nachblutung und zusätzliche Schwellung fördern.

Ernährung

- **Tag 1–2:** Flüssig – Suppe, Smoothie, Joghurt, Quark
- **Tag 3–5:** Weich – Püree, Nudeln, Fisch
- **Ab Tag 6:** Normal nach Befinden
- Heiße, scharfe, krümelige Speisen **meiden**
- Ziel: **1.500–2.000 kcal/Tag**
- Milchprodukte (Joghurt, Quark, Käse) **ausdrücklich erlaubt**
- Kein Strohhalm · Nicht auf OP-Seite kauen

Bitte ausreichend essen und trinken:

Zu wenig Energie und Flüssigkeit erhöht das Risiko für Kreislaufprobleme, Übelkeit, Erbrechen, schlechtere Schmerzmittel-Verträglichkeit, stärkere Schmerzen und verzögerte Wundheilung.

Schmerztherapie & Medikamente

Mittel	Einnahme	Hinweis
Ibuprofen 600	Alle 6–8 Std., max. 3×/Tag	Nicht nüchtern · Magenschutz bei Bedarf
Paracetamol 500–1000	Alternativ / ergänzend alle 6 Std.	Max. 4 g/Tag · kein Alkohol
Novalgin-Tropfen	Bis zu 4 × 30 Tropfen täglich	Bei stärkeren Schmerzen · mit Wasser einnehmen
<u>Kein Aspirin / ASS!</u>	<u>Absolut meiden</u>	Blutverdünnend → Nachblutungsgefahr
Antibiotikum	Falls verordnet – vollständig	Nicht eigenmächtig absetzen
Mundspülung	Ab Tag 2: Salbei oder CHX, sanft	Nicht direkt in Wunde · keine Munddusche
Zähneputzen	Ab Tag 2, Wundbereich aussparen	Weiche Bürste · nicht kräftig gurgeln

Tipp: Schmerzmittel **1 Stunde vor dem Eingriff** (auf Rezept) einnehmen – wirkt optimaler, wenn die Betäubung nachlässt.

Verkehr & Heimweg**Nach Lokalanästhesie**

Kein Auto, Fahrrad oder Motorrad. Heimweg zu Fuß oder mit ÖPNV erlaubt.

Nach Sedierung / Narkose

24 h nicht verkehrstüchtig. Abholung aus der Praxis durch Begleitperson verpflichtend. Kein Bus/Bahn.

Minderjährige: Erziehungsberechtigte Begleitperson zum Termin erforderlich.

8 · ZEITPLAN DER ERHOLUNG

1–2 TAGE Schwellung nimmt zu · Kühlphase · Bettruhe	3 TAG Schwellung am stärksten, klingt danach ab	3–5 TAGE AU Bürotätigkeit · körperl. Arbeit 7–10 Tage	7 TAGE Kein Sport · Sauna · Schwimmen · Sonnenbad	1–2 WOCHEN Fadenentfernung / Kontrolltermin	~6 MONATE Knochendefekt vollständig aufgefüllt
--	--	--	--	--	---

Häufige Fragen

Bleibt dauerhaft eine Lücke im Kiefer?

Nein. Das Zahnfleisch wird vernäht und wächst zügig zusammen. Der entstandene Knochendefekt füllt sich innerhalb von etwa 6 Monaten vollständig mit Knochen auf. Es bleiben keine knöchernen Narben und keine erhöhte Bruchgefährdung zurück.

Was zahlt die Krankenkasse?

Die gesetzliche Krankenkasse übernimmt Eingriff, Röntgen und Lokalanästhesie. Orale Sedierung per Tablette, Dämmerschlaf und Vollnarkose sind optionale Eigenleistungen (ca. 80–450 €).

Wie lange bin ich krankgeschrieben?

Am OP-Tag erhalten Sie eine Krankschreibung. Bürotätigkeit: ca. 3–5 Tage. Körperliche Arbeit: ca. 7–10 Tage. Individuell verschieden.

Was, wenn das Taubheitsgefühl dauerhaft bleibt?

Ein vorübergehendes Taubheitsgefühl nach Unterkiefereingriffen ist häufig und klingt in aller Regel innerhalb von Wochen bis Monaten vollständig ab. Dauerhafter Schaden ist sehr selten (unter 0,1 %). Sollte das Gefühl nach 4–6 Wochen nicht besser werden, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf – wir überweisen bei Bedarf zur neurologischen Kontrolle.

Wann darf ich wieder Sport machen?

Leichte Aktivität (Spaziergehen) ist ab Tag 3–5 möglich. Sport mit erhöhtem Puls (Joggen, Fitness, Schwimmen) erst nach **mindestens 7 Tagen** – bei ausgedehnten Eingriffen oder Knochenarbeit nach 10–14 Tagen. Kontaktsport und Tauchen: nach vollständiger Wundheilung (ca. 3–4 Wochen).

Soll man Weisheitszähne vorbeugend entfernen?

Nicht allein deshalb, weil ein Weisheitszahn vorhanden ist. Wenn aber Röntgenbild und Befund zeigen, dass zu wenig Platz besteht und eine Risikokonstellation vorliegt – zum Beispiel Teilretention, ungünstige Kippung, erschwerte Hygiene, wiederkehrende Entzündung, Karies-/Parodontitisrisiko, Zystenbildung oder drohender Schaden am Nachbarzahn –, ist eine Entfernung im Alter von etwa 14–25 Jahren häufig sinnvoll. Mit zunehmendem Alter wird ohne Beschwerden oder erkennbare Schädigung eher kontrolliert; bei Beschwerden, Entzündung oder Schaden wird therapeutisch entfernt.

SOFORT ANRUFEN BEI ...

- **Starke Nachblutung** – Tupfer hilft nicht nach 30 Min.
- **Schwellung nimmt zu** nach Tag 3–4 statt abzuklingen
- **Eiterbildung** oder stark fauliger Geruch / Geschmack
- **Kieferklemme**, die nicht nachlässt
- **Zunehmender Schmerz** ab Tag 3–5 trotz Schmerzmittel
- **Fieber** über 38,5 °C oder länger als 2 Tage anhaltend
- **Anhaltendes Taubheitsgefühl** an Lippe, Kinn oder Zunge

Bei Problemen nach dem Eingriff zuerst unsere postoperative Notfallnummer nutzen. Wenn wir nicht erreichbar sind: zahnärztlicher Notdienst 01805 60 70 11. Nur bei lebensbedrohlicher Notlage, Atemnot, starker Schluckbehinderung oder raschem Anschwellen von Mundboden, Hals oder Zunge: sofort 112 rufen.

Das sollten Sie nach dem Lesen mitnehmen

Wichtig: Diese Zusammenfassung ersetzt nicht die vollständige Information oben. Bitte lesen Sie die Seite einmal komplett durch, damit Sie im Aufklärungsgespräch gezielt Fragen stellen können.

- Die Entfernung wird empfohlen, wenn Weisheitszähne zu wenig Platz haben oder ein Risiko für Entzündungen, Nachbarzahnschäden, Zysten oder Hygieneprobleme besteht.
- Alle vier Weisheitszähne können seitenweise oder in einer Sitzung entfernt werden; wenn nichts dagegen spricht, ist eine Sitzung häufig sinnvoll, besonders bei Dämmerschlaf oder Vollnarkose.
- Die reine OP-Dauer bei vier Weisheitszähnen beträgt meist ca. 20–30 Minuten, der gesamte Termin ca. 60 Minuten.
- Standard ist die Lokalanästhesie. Sedierung oder Vollnarkose sind Komfortoptionen mit Begleitperson, Abholung aus der Praxis und besonderen Nüchternheitsregeln.
- Nach dem Eingriff sind konstantes Aufbeißen auf den Tupfer, richtiges Kühlen, ausreichendes Essen und Trinken sowie Rauchverzicht besonders wichtig.
- Sofortige Abklärung ist nötig bei starker Nachblutung, zunehmender Schwellung, Fieber, Eiter, zunehmenden Schmerzen oder Atem-/Schluckproblemen. Nach dem Eingriff zuerst unsere postoperative Notfallnummer nutzen; wenn wir nicht erreichbar sind: zahnärztlicher Notdienst 01805 60 70 11.

Checkliste vor Ihrem Termin

- ☐ Diese Seite vor dem Beratungstermin einmal vollständig durchlesen
- ☐ Offene Fragen notieren und zum Aufklärungsgespräch mitbringen
- ☐ Überweisung mitbringen, falls diese noch nicht vorliegt
- ☐ Röntgenbild mitbringen, falls es noch nicht vorliegt
- ☐ Überweisende Zahnarztpraxis bitten, das Röntgenbild vorab an uns zu übermitteln
- ☐ Aktuellen Medikamentenplan und bekannte Allergien bereithalten
- ☐ Bei Blutverdünnern, Bisphosphonaten/Antiresorptiva, Diabetes, Herzklappen- oder Endokarditis-Risiko: Unterlagen oder Ausweise mitbringen
- ☐ Medikamente gegen Diabetes oder zur Gewichtsreduktion (z. B. Ozempic, Wegovy, Mounjaro) vor Dämmer Schlaf oder Vollnarkose unbedingt angeben
- ☐ Bei Minderjährigen: erziehungsberechtigte Begleitperson mitbringen
- ☐ Bei Privatversicherten: Personalausweis mitbringen
- ☐ Bei Dämmer Schlaf oder Vollnarkose: Nüchternheitsregeln einhalten und Abholung aus der Praxis organisieren

PRAXIS ·
RÜCKFRAGEN

06151
786540

Nach dem Eingriff erhalten Sie unsere postoperative Notfallnummer. Wenn wir nicht erreichbar sind: zahnärztlicher
Notdienst 01805 60 70 11.

info@mkg-im-carree.de